

Blefaritis, orzuelo y chalazión

1. Introducción y relevancia clínica

Las **patologías inflamatorias de los párpados** —blefaritis, orzuelo y chalazión— son de las causas más frecuentes de consulta oftalmológica y de atención primaria.

Aunque habitualmente **no comprometen la visión**, producen **molestia ocular crónica**, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y enrojecimiento, pudiendo complicarse con infecciones o disfunción del borde palpebral.

Su relevancia clínica radica en:

- Alta prevalencia y recurrencia, especialmente en adultos y usuarios de lentes de contacto.
- Asociación con **disfunción de glándulas de Meibomio** y **rosácea ocular**.
- Posibilidad de **confusión con lesiones tumorales palpebrales** o infecciones graves (celulitis orbitaria).

En el contexto del **EUNACOM**, estos cuadros se evalúan por su valor semiológico y manejo inicial en APS, destacando la **diferencia entre lesiones agudas (orzuelo) y crónicas (chalazión o blefaritis)**, así como las indicaciones de derivación.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía funcional del párpado

Los párpados cumplen funciones de **protección, lubricación y distribución del film lagrimal**.

Sus estructuras principales incluyen:

- **Glándulas de Meibomio (sebáceas modificadas)**: secretan la capa lipídica de la lágrima.
- **Glándulas de Zeis y Moll**: ubicadas en el borde palpebral, asociadas a folículos pilosos.
- **Músculo orbicular, tarso y conjuntiva tarsal**.

El borde palpebral normal mantiene una flora bacteriana equilibrada (principalmente *Staphylococcus epidermidis* y *Propionibacterium acnes*), pero alteraciones locales o sistémicas pueden favorecer inflamación.

2.2 Blefaritis

La **blefaritis** es la inflamación crónica del borde palpebral.

Se clasifica en:

1. **Anterior:** afecta la base de las pestañas y glándulas de Zeis y Moll.
 - Causa: infección estafilocócica o dermatitis seborreica.
2. **Posterior:** afecta glándulas de Meibomio (meibomitis).
 - Causa: disfunción de Meibomio asociada a rosácea o hipersecreción sebácea.

Fisiopatología:

La obstrucción glandular y la proliferación bacteriana alteran la composición lipídica de la lágrima, generando inflamación crónica y alteración del film lagrimal → ojo seco secundario.

2.3 Orzuelo

El **orzuelo (hordeolum)** es una **infección aguda purulenta** de las glándulas palpebrales.

- **Externo:** infección de glándulas de Zeis o folículo piloso.
- **Interno:** infección de glándulas de Meibomio.

Agente etiológico más común: **Staphylococcus aureus**.

Se caracteriza por inflamación dolorosa, localizada y con pus visible o palpable.

El proceso suele resolverse espontáneamente en 5–7 días.

2.4 Chalazión

El **chalazión** es una **reacción inflamatoria crónica granulomatosa** causada por la **obstrucción estéril** del conducto de una glándula de Meibomio.

A diferencia del orzuelo:

- Es **indoloro**.
- De crecimiento **lento y subagudo**.
- Puede persistir semanas o meses.

La acumulación de secreción sebácea induce una respuesta inflamatoria tipo cuerpo extraño. En algunos casos se infecta secundariamente o genera deformidad estética del párpado.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Blefaritis

Síntomas:

- Sensación de arenilla o ardor ocular.
- Enrojecimiento del borde palpebral.
- Costras o escamas en la base de las pestañas.
- Picazón, lagrimeo, visión borrosa transitoria.

Signos:

- Bordes palpebrales engrosados, eritematosos.
- Secreción seca adherida a pestañas (“collarete”).
- Taponamiento de orificios de Meibomio.
- En casos crónicos: madarosis (pérdida de pestañas), triquiasis, conjuntivitis asociada.

Diagnóstico diferencial: dermatitis seborreica facial, rosácea ocular, conjuntivitis alérgica.

3.2 Orzuelo

Síntomas:

- Dolor localizado y sensibilidad al tacto.
- Edema palpebral, eritema y calor local.
- Sensación de cuerpo extraño.

Signos:

- Pápula o nódulo inflamatorio eritematoso en el borde palpebral.
- Puede drenar espontáneamente al exterior (orzuelo externo) o al tarso (interno).

Diagnóstico diferencial: chalazión (no doloroso), celulitis preseptal (más difusa), absceso palpebral.

3.3 Chalazión

Síntomas:

- Masa palpebral indolora, redondeada.
- Puede causar molestia estética o leve peso.
- En lesiones grandes: compresión del globo ocular y astigmatismo.

Signos:

- Nódulo firme, móvil, sin signos inflamatorios agudos.
- No adherido a piel, pero sí al tarso.
- Puede observarse contenido sebáceo amarillento por eversión palpebral.

Diagnóstico diferencial: orzuelo (doloroso y agudo), tumor palpebral (carcinoma sebáceo o basocelular si recidiva).

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico es **clínico**, basado en la historia y el examen físico.

Exámenes complementarios (solo en casos atípicos o recidivantes):

- **Cultivo bacteriano:** si hay secreción purulenta persistente o inmunosupresión.
- **Biopsia:** en lesiones crónicas o recurrentes para descartar carcinoma sebáceo o basocelular.
- **Evaluación dermatológica:** si se sospecha rosácea o dermatitis seborreica.

Criterios diagnósticos clínicos:

Patología	Dolor	Evolución	Localización	Secreción	Curso
Blefaritis	Leve / ausente	Crónica	Borde palpebral difuso	Costras secas	Recurrente
Orzuelo	Doloroso	Agudo (5–7 días)	Glándula / folículo	Pus	Autolimitado
Chalazión	Indoloro	Subagudo / crónico	Tarso	No	Puede persistir meses

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Medidas generales

Comunes a todas las formas:

- **Higiene palpebral diaria:** compresas tibias 2–3 veces al día y limpieza del borde palpebral con gasa o champú neutro infantil diluido.
 - **Evitar maquillaje y lentes de contacto** durante la fase activa.
 - **Control de rosácea o dermatitis seborreica** si están presentes.
-

5.2 Blefaritis

- **Tratamiento local:**
 - Compresas tibias + masaje suave del borde palpebral.
 - Limpieza con champú neutro o toallitas específicas.
 - Lágrimas artificiales si hay ojo seco.
 - **Antibióticos tópicos (si hay componente infeccioso):**
 - Eritromicina o bacitracina ungüento 2 veces al día durante 1–2 semanas.
 - **Casos crónicos o recidivantes:**
 - Doxiciclina VO 100 mg/día por 2–4 semanas (modula secreción meibomiana).
 - **Evitar corticoides tópicos prolongados.**
-

5.3 Orzuelo

- **Compresas calientes** 10–15 min, 3–4 veces/día.
 - **Antibióticos tópicos** (eritromicina o bacitracina) si hay secreción.
 - **No manipular ni exprimir.**
 - **Antibióticos sistémicos (doxiciclina o cloxacilina)** solo si hay celulitis preseptal o compromiso difuso.
 - Si persiste >1 semana o hay absceso → **incisión y drenaje** bajo anestesia local por oftalmólogo.
-

5.4 Chalazión

- **Medidas conservadoras:**
 - Compresas tibias y masaje palpebral por varias semanas.

- Si persiste >4–6 semanas o produce deformidad estética:
 - **Inyección intralesional de triamcinolona** (0,1 mL de 10 mg/mL).
 - O bien **escisión quirúrgica** (curetaje) bajo anestesia local.
- Lesiones recurrentes o atípicas → derivar a **biopsia**.

6. Complicaciones y pronóstico

Patología	Complicaciones	Pronóstico
Blefaritis	Conjuntivitis crónica, triquiasis, chalazión recurrente, ojo seco	Crónico, requiere higiene constante
Orzuelo	Absceso, celulitis preseptal, chalazión residual	Excelente si se drena espontáneamente
Chalazión	Infección secundaria, deformidad palpebral, sospecha de tumor	Muy bueno; recidiva si no se trata causa base

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Blefaritis = inflamación crónica; orzuelo = infección aguda; chalazión = obstrucción crónica estéril.**
2. El **tratamiento inicial siempre incluye higiene palpebral** con compresas tibias.
3. La **doxiciclina oral** mejora la secreción meibomiana en blefaritis crónica.
4. **Chalazión recurrente en el mismo sitio** debe biopsiarse para descartar carcinoma sebáceo.

5. En **rosácea ocular**, tratar también la rosácea facial.
6. **No usar corticoides tópicos sin supervisión oftalmológica.**
7. En orzuelo, si hay fiebre o extensión, pensar en **celulitis preseptal**.

Errores comunes

- Indicar antibióticos orales de rutina en orzuelos simples.
 - No instruir higiene palpebral crónica en blefaritis.
 - Confundir chalazión con tumor maligno (carcinoma sebáceo).
 - Aplicar compresas frías en lugar de tibias.
 - No derivar chalazión persistente o recidivante.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Blefaritis, orzuelo y chalazión** son procesos inflamatorios del borde palpebral con mecanismos distintos: infección aguda, inflamación crónica y obstrucción glandular.
2. **Blefaritis:** requiere higiene palpebral prolongada y, en casos crónicos, doxiciclina oral.
3. **Orzuelo:** infección aguda estafilocócica; compresas calientes y antibióticos tópicos son primera línea.
4. **Chalazión:** indoloro y crónico; si no cede, requiere corticoide intralesional o escisión quirúrgica.
5. **No se exprimen ni se manipulan las lesiones palpebrales.**
6. **Toda lesión palpebral recurrente o atípica debe biopsiarse.**
7. **Pronóstico excelente**, pero requieren educación en higiene para evitar recurrencia.